

Wypalenie w ciele

Ciało często wie pierwsze. Somatyzacja wypalenia bywa wcześniejsza niż świadomość emocjonalna.

CZAS: 10 min audytu 4 tygodnie dziennika

ŹRÓDŁO: Melamed i in. (2006); Salvagioni i in. (2017, meta-analiza, k = 61); Cohen & Janicki-Deverts (2012); McEwen (1998)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **checklist objawów somatycznych**: osiem kategorii do oznaczenia, które masz teraz. W sekcji 02 — **dwie ścieżki równoległe**: wykluczenie organiczne i adresowanie wypalenia jako źródła. Sekcja 03 — **statystyki ryzyka** z metaanalizy Salvagioni i in. (2017). Sekcja 04 — krótki dziennik somatyczny na 4 tygodnie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wypalenie jest chorobą **całego ciała**, nie tylko psychiki. Melamed i in. (2006): wypalenie wiąże się z chroniczną aktywacją osi HPA (podwyższony kortyzol), układu współczulnego (podwyższone ciśnienie, tachykardia) i systemu zapalnego (podwyższone CRP, IL-6). Salvagioni i in. (2017, metaanaliza prospektywnych badań, k = 61): wypalenie jest predyktorem cukrzycy typu 2 (OR = 1,84), choroby wieńcowej (OR = 1,40), hospitalizacji z jakiegokolwiek przyczyny (OR = 1,57), bólu mięśniowo-szkieletowego (OR = 1,55) i zmęczenia przedłużonego (OR = 3,96). Typowe objawy somatyczne wypalenia: chroniczne zmęczenie nieproporcjonalne do wysiłku, napięciowe bóle głowy, napięcie mięśniowe (kark, plecy, szczeka), bezsenność lub nadmierna senność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (objawy *IBS-like*), częste infekcje przy obniżonej odporności (Cohen i Janicki-Deverts, 2012), spadek libido, zmiany apetytu i masy ciała. Klinicznie kluczowe: **somatyka bywa pierwsza**. Pacjent przychodzi do lekarza pierwszego kontaktu z bólami głowy, problemami żołądkowymi lub bezsennością — *zanim* sam zauważy, że to wypalenie. Dlatego dwie ścieżki muszą iść równoległe: **wykluczenie organiczne** (badania, konsultacja lekarska) oraz **adresowanie wypalenia jako źródła**. Bez obu — chroniczycyzacja somatyczna i nieskuteczne leczenie objawowe.

01 Body audit — checklist objawów

Zaznacz objawy, które **obserwujesz u siebie** w ostatnich 4 tygodniach. Trzy lub więcej zaznaczonych = wyraźny sygnał somatycznego komponentu wypalenia.

☐ **Zmęczenie nieproporcjonalne** — wstajesz wyczerpany/-a po 8 h snu; popołudniowe „padanie”.

☐ **Bóle głowy napięciowe** — opaska wokół głowy, ucisk skroni, częstotliwość rośnie.

☐ **Napięcie mięśniowe** — bark, kark, szczeka. Może pojawić się bruksizm (zgrzytanie zębami w nocy).

☐ **Bezsенność lub nadmierna senność** — trudność z zasypianiem, budzenie w nocy, lub odwrotnie: senność po południu, długi sen bez regeneracji.

☐ **Problemy żołądkowo-jelitowe** — wzdęcia, biegunka lub zaparcia, ból brzucha, objawy podobne do *IBS*.

☐ **Częste infekcje** — przeziębienia co kilka tygodni, opryszczki, wolniejsze gojenie ran (Cohen 2012).

☐ **Spadek libido** — obniżone zainteresowanie seksualne; zaburzenia erekcji lub cyklu menstruacyjnego.

☐ **Zmiany masy ciała** — utrata lub przyrost > 5% bez zmian w diecie; wzrost spożycia węglowodanów/cukru.

02 🕒 Dwie ścieżki — równoległe, nie zamiast siebie

ŚCIEŻKA 1 · WYKLUCZENIE ORGANICZNE

Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu lub medycyny pracy. Podstawowe badania: morfologia, lipidogram, glukoza/HbA1c, TSH (tarczycza), CRP, ciśnienie. Cel: wykluczyć, że objawy mają *oddzielną* etiologię (niedoczynność tarczycy, niedokrwistość, cukrzyca).

ŚCIEŻKA 2 · ADRESOWANIE WYPALENIA

Jeśli wyniki są w normie, ale objawy się utrzymują — **nie znaczy** to, że „nic ci nie jest”. Znaczy, że źródło jest psycho-somatyczne (chroniczny stres). Interwencje na wypalenie + interwencje somatyczne (sen, ruch, oddech, dieta) — równoległe, miesiącami.

03 ❓ Statystyki ryzyka — metaanaliza Salvagioni (2017)

Przegląd 61 prospektywnych badań. Wypalenie jest niezależnym predyktorem chorób somatycznych — ryzyko wzrasta o 40–300% w zależności od schorzenia.

SCHORZENIE	ILORAZ SZANS (OR)	WZROST RYZYKA
Zmęczenie przedłużone (> 6 mies.)	3,96	~300% wyższe
Cukrzyca typu 2	1,84	~84% wyższe
Hospitalizacja (z dowolnej przyczyny)	1,57	~57% wyższe
Ból mięśniowo-szkieletowy	1,55	~55% wyższe
Choroba wieńcowa	1,40	~40% wyższe

04 📅 Dziennik somatyczny — 4 tygodnie

Raz w tygodniu (np. niedziela wieczorem) — krótki audyt. Trend pogorszenia 2 tyg. z rzędu = wizyta lekarska.

TYDZIEŃ	ENERGIA (0–10)	SEN (H/JAKOŚĆ)	LICZBA OBJAWÓW Z SEC. 01	NOTATKA
Tydz. 1				
Tydz. 2				
Tydz. 3				
Tydz. 4				

Klucz: ciało często wie pierwsze. Somatyzacja wypalenia bywa *wcześniejsza* niż świadomość emocjonalna — pacjent przychodzi do lekarza z bólami głowy, problemami żołądkowymi, częstymi infekcjami **zanim** sam zauważy, że to wypalenie. Brak organicznej etiologii w badaniach nie znaczy, że „nic ci nie jest” — znaczy, że źródło leży w chronicznym stresie i wymaga adresowania na poziomie wypalenia. Sen, ruch, oddech, dieta — to wymierne interwencje, nie modny *self-care*.

⚠️ *Jeżeli zauważasz nagłą lub gwałtowną zmianę objawów somatycznych (duszność, ból w klatce piersiowej, omdlenia, krwawienie, gwałtowne chudnięcie) — pilna konsultacja lekarska. Nie zakładaj, że „to wypalenie”.*